

전립선암 진단 첫 30일

위험군 · 능동감시 · 수술과 방사선 선택

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 07

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

전립선암은 ‘위험군’에 따라 지켜보기부터 적극적 치료까지 길이 넓습니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Prostate Cancer, Version 7.2026 외 국내 자료 (본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: PSA 상승과 암 확진, 능동감시와 대기관찰

30초 요약

- **PSA가 높다 ≠ 암.** 전립선비대증·염증으로도 오릅니다. 확진은 조직검사로 합니다.
- 치료는 **위험군**(저·중간·고·초고위험, 일부 지침은 저위험 안에 초저위험을 따로 구분)에 따라 달라집니다. 최근 개정에서 위험군 구분이 일부 바뀌어 오래된 자료와 다를 수 있습니다.
- **능동감시**(정기 검사로 지켜보다 필요할 때 근치 치료)와 **대기관찰**(증상이 생길 때 증상 치료)은 다른 전략입니다. 국내 병원·자료에서는 능동감시를 '**적극적 관찰(치료)**'이라고 부르기도 하고 두 말을 섞어 쓰기도 하니, "정기 MRI·조직검사를 하다가 근치 치료로 넘어가는 방식인가요?"라고 확인하세요.
- 수술과 방사선은 적합한 환자에서 **성적이 비슷하고 부작용 양상이 다릅니다.** 우열이 아니라 나에게 맞는 선택입니다.

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직검사 결과(등급군·양성 코어 수) 확인, MRI 시행 시점 확인	Day 0-3
②	위험군 판정, 필요 시 병기 검사(PSMA PET 등)	Day 3-14
③	배선 유전검사 대상 여부	첫 진료
④	능동감시 / 수술 / 방사선(± 호르몬) 결정 — 양쪽 진료과 상담	Day 10-30

오늘 물어볼 질문

1. 제 등급군과 위험군은 무엇인가요?
2. 능동감시가 가능한가요?
3. 수술과 방사선을 모두 상담받을 수 있나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- 조직검사 후 38°C 이상 발열·오한(감염, 패혈증 가능성), 소변을 전혀 못 봄, 많은 혈뇨·핏덩이
- 소변이 막혀 아랫배가 부풀고 아픔
- 첫 호르몬 주사 후 1~2주 뼈 통증 악화·다리 힘 빠짐·소변 막힘(플레이어 현상)
- 등 통증 + 다리 힘 빠짐·감각 저하·대소변 장애(척수 압박)
- 항암 중 38°C 이상 발열
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 조직검사 후 소량의 혈뇨·혈정액·혈변은 몇 주간 흔합니다. 그러나 **발열·오한, 소변 막힘, 많은 출혈**은 바로 연락합니다. 직장을 거쳐 하는 조직검사 뒤 패혈증이 약 2%에서 생길 수 있고, 회음부로 하는 방법은 감염 위험이 더 낮다고 알려져 있습니다. 재조직검사를 받게 되면 어떤 방법인지 물어보세요.
2. 요폐는 도뇨가 필요합니다.
3. 일부 호르몬 주사(작용제)는 초기에 일시적으로 남성호르몬이 오르며 증상이 악화될 수 있어, 이를 막는 약을 먼저 쓰기도 합니다. 이런 현상이 없는 종류도 있으니 내 약이 어떤 종류인지 물어보세요.
4. 척추 전이에 의한 신경 압박은 시간이 중요합니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과지 받기 ② 복용 약(특히 전립선비대증·탈모약) 정리 ③ 배우자·파트너와 함께 진료받을지 정하기.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과지 — 등급군(Grade Group), 양성 코어 수와 비율
- ☐ **5알파환원효소억제제**(전립선비대증·탈모약: 피나스테리드·두타스테리드 등) 복용 여부와 기간 기록 — **PSA가 약 절반 정도로 낮게 측정될 수 있습니다**
- ☐ 배우자·파트너와 동반 진료 정하기 — 기능 결과(배뇨·성기능) 결정에 도움이 됩니다

이번 주 할 일

- ☐ 전립선 MRI가 조직검사 **전/후** 언제 시행됐는지 확인(없다면 추가 필요 여부 질문)
- ☐ 조직검사 전 MRI와 PSMA PET/CT는 2022년부터 일부 조건에서 건강보험 급여가 됩니다. 내 경우 급여 대상인지 담당의·원무과에 확인(2026.10 기준, 확인 필요)
- ☐ 가족력(전립선·유방·난소·췌장암) 정리 → **배선 유전검사** 대상 여부(고위험·전이·가족력)
- ☐ 산정특례 신청(C61, 확진일로부터 30일 이내; 능동감시를 하더라도 조직검사로 확진되면 신청할 수 있는지 원무과 확인)

오늘 물어볼 질문

1. 제 PSA와 MRI, 조직검사 결과를 어떻게 종합하나요?
2. 추가 병기 검사가 필요한가요?
3. 유전검사 대상인가요?

4장. 등급군과 위험군

30초 요약: 글리슨 점수는 현재 **등급군(GG) 1~5**로 표기합니다. 위험군은 PSA·등급군·병기(T)·양성 코어 수로 정합니다.

등급군	글리슨 점수	쉬운 뜻
GG1	3+3=6	가장 낮은 등급
GG2	3+4=7	낮은~중간
GG3	4+3=7	중간
GG4	8 (4+4, 3+5, 5+3)	높음
GG5	9~10	가장 높음

위험군(개념)	흔한 선택지
저위험(일부 지침의 초저위험 포함)	능동감시가 우선 권고되는 경우가 많음 , 수술·방사선도 가능
중간위험(양호/불량)	양호한 일부는 능동감시, 수술 또는 방사선(± 단기 호르몬)
고위험·초고위험	수술(± 추가치료) 또는 방사선 + 장기 호르몬, 초고위험 일부는 2세대 항안드로겐제(ARPI) 병용 범주
림프절 전이	방사선 + 호르몬(± ARPI) 등
원격전이	호르몬치료 + ARPI ± 항암

- PSMA PET에서 보이는 것이 곧 확정 전이는 아닙니다. 판독 표현(의심/가능성/확실)을 그대로 적고 치료 방향이 바뀌는지 확인하세요.

■ 완전판에서 이어집니다 — 내 병리보고서에서 찾을 단어 5개, 수술 후 병리와 추가치료

내 기록: PSA _ · 5알파환원효소억제제 ☐없음 ☐복용(_개월) · MRI(PI-RADS) _ ·
GG _ · 양성 코어 _/_ · 위험군 _ · **PSMA PET** _

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 능동감시

30초 요약: 저위험(및 양호한 중간위험 일부)은 **능동감시**가 표준 선택지입니다. 정기 PSA·MRI·재조직검사로 지켜보다가 **등급 상승·MRI 변화** 등이 있으면 근처 치료로 넘어갑니다.

- 능동감시 중에도 언제든지 치료를 원하면 상의할 수 있습니다.
- 국소치료(병변만 태우거나 얼리는 치료)는 아직 표준 대체 치료로 일상적으로 쓰지 않으므로 신중히 상의합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 능동감시 일정 예시와 기록표, 장기 불안 관리

6장. 수술 vs 방사선

30초 요약: 수술과 방사선이 모두 가능하면 **비뇨의학과와 방사선종양학과 양쪽 상담(또는 다학제 진료)**을 요청할 수 있습니다. 방사선은 방법에 따라 **5회 정도부터 수주까지** 통원 횟수가 다양합니다.

- 수술 뒤에는 정액이 만들어지지 않아 오르가즘은 느껴도 사정은 되지 않고, 자연 임신이 어렵습니다. 방사선·호르몬치료도 생식 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 자녀 계획이 있다면 **치료 전에 정자 보관**을 상의하세요.

비교 (범주)	근치적 전립선절제술(로봇 등)	방사선(± 호르몬)
배뇨	초기 요실금이 흔하고 대부분 수개월~1년에 걸쳐 회복	빈뇨·급박뇨 등 자극 증상

비교 (범주)	근치적 전립선절제술(로봇 등)	방사선(± 호르몬)
성기능	발기 기능 저하 흔함(신경 보존 여부·나이에 따라)	서서히 저하될 수 있음
장	영향 적음	직장 자극·출혈 가능
통원	입원 수일	5회~수주 통원
호르몬 비용	보통 없음	위험군에 따라 단기~장기
호르몬 비용	보통 없음	위험군에 따라 약 6개월(불량 중간위험)~18~36개월(고위험)

■ **완전판에서 이어집니다** — 수술·방사선 결정 워크시트, 수술 전 골반저근 운동, 방사선 방법별 비교

7장. 호르몬치료(ADT)

30초 요약: 남성호르몬을 낮추는 치료로, 방사선과 함께(고위험) 또는 전이성에서 씁니다. 안면홍조·피로·근육 감소·체중 증가·성욕 저하·**뼈 약화**·기분 변화가 흔합니다.

- **주 2회 이상 근력운동 + 걷기** 등 유산소가 부작용을 줄입니다. 뼈 전이가 있으면 운동 제한을 확인하세요.
- 뼈 보호 주사를 권유받으면 **시작 전 치과 검진**을 받고, 발치 등 치과치료 전 담당의에게 알려세요.
- 기분·수면·기억력 변화도 말해도 되는 부작용입니다.

8장. 전이성 전립선암

30초 요약: 전이성 호르몬감수성 전립선암은 호르몬치료 + 2세대 항안드로겐제(ARPI) ± 항암(삼제) 범주가 표준입니다. 이후 거세저항성이 되면 PARP 억제제(유전자 변이 시)·방사성리간드치료·항암 등 후속 범주가 있습니다(국내 허가·급여 확인 필요).

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

남성성·성기능·관계

30초 요약: 배뇨·성기능 변화와 남성성에 대한 걱정은 흔하며, 의료진에게 말하는 것이 자연스러운 일입니다. 발기부전 치료(약·주사·기구·보형물)와 성재활이 있습니다. 배우자·파트너와 함께 진료받는 것을 권합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 배우자와의 대화, ADT 중 기분·수면 기록

추적

- 치료 후 PSA를 정기적으로 확인합니다. 수술 후에는 PSA가 거의 0으로, 방사선 후에는 서서히 떨어집니다. **PSA 재상승**은 영상 등으로 확인하며, 곧바로 증상이 있는 재발을 뜻하지는 않습니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀝니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 등급군과 양성 코어 수는요? 2. 위험군은 무엇인가요? 3. MRI·PSMA PET이 필요한가요? 4. 능동감시가 가능한가요? 5. 수술과 방사선 양쪽 상담을 받을 수 있나요? 6. 각 치료의 배뇨·성기능·장 영향은요? 7. 호르몬치료가 필요하다면 기간은요? 8. 유전검사 대상인가요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 치료 후 PSA는 어떻게 추적하나요?

내 전립선암 한 장 요약

항목	내 기록
PSA(진단 시)	_____ (5알파환원효소억제제 □)
등급군	GG _____
양성 코어	___/___
MRI / PSMA PET	___/___
위험군	_____
첫 치료	능동감시 / 수술 / 방사선 ± 호르몬 / 전신치료
유전검사	_____
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 위험군은? ② 능동감시가 가능한가요? ③ 수술과 방사선의 차이는 제게 어떤 의미인가요?

■ 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 전립선암 용어사전
- 전립선암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크 달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Prostate Cancer, Version 7.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 전립선암 정보, 대한비뇨의학회·대한비뇨기종양학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 쓰지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 쓰지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.

- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 내 병리보고서에서 찾을 단어 5개, 수술 후 병리와 추가치료
- 능동감시 일정 예시와 기록표, 장기 불안 관리
- 수술·방사선 결정 워크시트, 수술 전 골반저근 운동, 방사선 방법별 비교
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 배우자와의 대화, ADT 중 기분·수면 기록
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 전립선암 용어사전

- 전립선암 자주 묻는 질문 12
 - 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
 - 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>